EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 86221
SERVICIO	: UNIDAD EMERGENCIAS		
FECHA	: 2024-06-07 10:56:20		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SERGIO ANTONIO MELLA MELLA			**RUN**	: 4.190.244-2
F.Nac	: 20-02-1938	**Edad**	: 86 AÑOS, 3 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: NUEVA ESPERANZA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 967875691		
Fecha Ingreso	: 07-06-2024	**Fecha Egreso**	: 2024-06-07 10:56:20	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	: OTRO SERVICIO DE SALUD

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ITU

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AM. 2 IAM HTA DLP FA PAROXISTICA
ALERGIAS. NO

Paciente con antecedentes de HTA, DLP. Hospitalizacion reciente por IAM c/SDST enfermedad severa de un vaso (ADA media), durante hospitalizacion con peak febril y alza de parametros inflamatorios, cultivos negativos se manejo con ceftriaxona por 5 dias. Dado de alta el 13/05/24. Ultima consulta el 18/05 por cuadro de dolor toracico y CEG, ECG con T negativas T negativa v3-v6. DI DII DIII, AVL Y AVF, exámenes de laboratorio y destaca
Troponina : 1.080, DD 4407, K 6.1. Se presenta a hemodinamista, descarta manejo activo hasta estabilización de paciente. Sin disponibilidad de camas UCI. Se indica a medico de urgencia que presenta caso a HCHM.

Paciente consulta hoy 6/6/24 por cuadro de dolor abdominal de 2 dias evolucion, CEG moderado. Ingresa estable./Ex control: glicemia 115, crea 1.1, amilasa 102 lipasa 207, GPT 141, GOT 87, PCR 169, UREMIA 74, gb 10000, Hb 11.4, INR 1.63, TROPONINA 44, OC inflamatoriacon nitritos (+), leucos 5-10.
Se realiza curva de troponinas:
48.4.
Se descarta IAM.
ECG: RS, FC 85, ONDA Q V2-V5, T(-) V1. No evolutivo a previo.

Al examen fisico
Hidratado
Sin dolor torácico
MP + RR2, TONOS APAGADOS

ABD SENSIBLE EN HIPOGASTRIO, SIN GLOBO VESICAL
EEII sin edema o signos de TVP. Tibias

Paciente cursando con ITU, se deriva a HODOM para manejo con terapia antibiotica EV.

PLAN DE MANEJO:

Antibioticoterapia EV

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen diabético hiposódico
3. Hidratacion oral restriccion hidrica de 1000cc
4. Ceftriaxona 2g/día EV (1/7)
5. Paracetamol 500 mg, 2 comprmidos c/8 hrs por 7 días VO
6. Tratamiento crónico:
7. AAS 100MG
8. Amiodarona 200mg 1/2 dia
9. Bisprolol 2.5 dia
10. Clopidogrel 75mg
11. Famotidina 40
12. Furosemida 40 mg: 1/2 c/12h
13. Espironolactona 25mg: 1/2 c/12h
14. Dabigatran 110 mg c/12h
15. Examenes en 48h (Rcto globular, BUN, Creatinina, ELP, PCR)
16. Acudir a urgencias SOS

OBSERVACIONES:

Manejo por HODOM

Giovanni Sánchez Troncoso
MEDICO TRATANTE
19823365-K

JEFE SERVICIO